

תקציר מנהלים

אתגר מרכזי הגלום בעלייה בתוחלת החיים בישראל הוא השאיפה להבטיח כי הזדקנות האוכלוסייה תהיה מלווה בשימור איכות חייהם של האזרחים הוותיקים. לפיכך, ביום 17.1.2022 החליטו שר הרווחה והביטחון החברתי, חה"כ מאיר כהן, ושר הבריאות, חה"כ ניצן הורוביץ, על הקמת צוות בין-משרדי שמטרתו בחינת כלל המענים הניתנים כיום לאוכלוסייה הוותיקה לצורך שימור תפקודה – ובראשם גמלת הסיעוד – ולגבש המלצות בנושא.

ההגדרה "הידרדרות תפקודית בת מניעה" – האופן בו בחר הצוות להגדיר את הבעיה שלפתחו – שואפת לגלם את התפיסה שהוכתבה בכתב המינוי, המבקשת להציב במרכז את אוכלוסיית האזרחים הוותיקים בישראל ורווחתה. בראי הגדרה זו בוצע במסגרת העבודה מיפוי של הגורמים המרכזיים, הפיזיים והקוגניטיביים, העשויים לתרום להידרדרות תפקודית בקרב אזרחים ותיקים, וזוהו הבעיות והחסמים העיקריים המונעים מהמגזר הציבורי בישראל לספק שירותי מניעת הדרדרות לאוכלוסייה זו.

ממצאיו העיקריים של הצוות היו כי נכון להיום לא רק שלא קיים בישראל גוף שתכליתו העיקרית היא שימור תפקוד ומניעת הדרדרות תפקודית בת מניעה, אלא שגם לגופים הקיימים אין תמריץ משמעותי, אם בכלל, לדאוג לדחיקת התלות של האזרחים הוותיקים. הדבר נובע, בין השאר, ממאפיינים מבניים במערכת אספקת השירותים הציבוריים לאזרחים ותיקים המקשים על הגשמתה של מטרת מניעת ההידרדרות: כיום מפוצלים השירותים בתחום התפקוד ומניעת ההידרדרות בין גורמים שונים – משרדי ממשלה וגופים פרטיים – הנעדרים ראייה כוללת של האזרח הוותיק והרצף הטיפולי, ממוקדים כמעט במלואם בטיפול עם השקעה מועטה במניעה, ולעתים אף גלומים בהם תמריצים שליליים לדחיקת תלותם של הקשישים בעזרת הזולת, בשל הרווחים שבאספקת שירותים סיעודיים לזכאי הגמלה נוסף על כך, הטיפול באזרח הוותיק מתחיל לאחר שסבל מהדרדרות תפקודית ונכנס להגדרה של זכאי לגמלת סיעוד, ואין מדיניות ממשלתית מוסדרת לשימור הבריאות ומניעת ההדרדרות מלכתחילה.

המסקנה העיקרית אליה הגיע הצוות היא שיש לשנות את סדרי העדיפויות בטיפול הסיעודי בישראל באופן דיפרנציאלי, כך שהמשאבים המושקעים כיום ברמות הסיעוד הנמוכות לצורכי טיפול יופנו ברובם לטובת שירותי מניעת הדרדרות. אופן הקצאת המשאבים יוודא כי לספקי השירותים למניעת הדרדרות יהיה את הידע, היכולת והפריסה הארצית לטובת אספקת השירותים באופן מיטבי, וכן ירחיב את מרחב הגמישות לספקים עבור התאמה אישית של סוג השירות, תוך שימת דגש מיוחד על מנגנון ההקצאה אשר יכלול תמריצים כלכליים למניעת הדרדרות.

לפיכך, גיבש הצוות מספר עקרונות מרכזיים, עליהם ביסס את המלצותיו. עקרונות אלה כוללים השקעה משמעותית במניעת הדרדרות באוכלוסייה הרלוונטית, הכנסת שירותי דחיקת תלות ברמות הנמוכות של גמלת הסיעוד, שילוב משמעותי של קופות החולים באספקת שירותי מניעת הדרדרות, הרחבת שירותי הרווחה בגמלת הסיעוד, שינוי מבנה התמריצים בגמלת הסיעוד כך שיעודדו דחיקת תלות, חיזוק מעמד המטפלות הסיעודיות והגברת שיתוף הפעולה והסנכרון בין הגופים השונים.

ההמלצות, הנגזרות ממסקנות ועקרונות אלו, הן:

א. שינוי מבנה גמלת הסיעוד ברמות הנמוכות (רמות 1-2)

המלצה זו, הנוגעת למקבלי גמלת הסיעוד ברמות הנמוכות, היא ההמלצה העיקרית והמשמעותית של הצוות. בהמשך לבחינת סוגיית הטיפול הניתן היום לקשישים ברמות הנמוכות, ולאור ההיקף הנרחב של קשישים הזכאים לשירותי סיעוד בישראל כפי שבא לידי ביטוי בהשוואות הבינלאומיות, החליטו חברי הצוות כי בהינתן המצב הקיים, ועל מנת שלא לגרוע מסך המשאבים המוקצים עבור אוכלוסייה זו, יהיה נכון יותר להתמקד בשירותי מניעה ברמות הנמוכות, ולא בשירותי טיפול, הן בשל העובדה כי קשישים אלה חווים ירידה לא משמעותית בתפקודם, והן בשל האפקטיביות הגדולה של שירותי המניעה בשלב זה. גמלת הסיעוד תשתנה כך שתהא מורכבת מהרכיבים הבאים:

1. קצבה חודשית לאזרח הוותיק. קצבה כספית אשר תינתן לאזרח הוותיק דרך המוסד לביטוח לאומי, ללא הגבלה על אופי השימוש בקצבה.

2. שירותי מניעה – רכש של ביטוח לאומי ואספקה במסגרת לוח ח'2 לחוק או אספקה באמצעות קופות החולים. שתי החלופות האמורות ייבחנו בהמשך לצורך הכרעה בדבר המנגנון המיטבי והישים ביותר על מנת לסייע לאזרחים הוותיקים בצורה האופטימלית.

3. שירותי רווחה מלוח ח'2. הצוות ממליץ כי רובד מסוים משירותי הרווחה יהיה רובד מחייב, כך שאזרח ותיק לא יוכל להמיר את השירות האמור בקצבה בכסף.

ב. שינוי מבנה התמריצים לחברות ועמותות הסיעוד. שינוי מבנה התמריצים במכרז הסיעוד של הביטוח הלאומי כך שיעודד מניעת הידרדרות ודחיקת תלות.

ג. שילוב משמעותי של קופות החולים במהלכים למניעת הדרדרות טרם המצב הסיעודי וברמות הנמוכות של הגמלה. ע"י מתן תמריצים לקופות החולים בתחומים הבאים: מניעת ודחיקת הדרדרות תפקודית של אזרחים ותיקים שטרם הגיעו למצב סיעודי; שימור תפקוד ודחיקת הדרדרות של אזרחים ותיקים ברמות 1-2 של גמלת הסיעוד. מימון השירותים יתבצע או באמצעות תכניות המניעה האמורות בסעיף א (2), או באמצעות מבחני תמיכה לקופות החולים, עבור פעולות מניעה רפואית שנמצאות בתחום המומחיות של הקופות ותוך שמירה על איתנותן הכלכלית.

ד. חיזוק תכניות למניעת הדרדרות תפקודית המיועדות לאזרחים ותיקים עצמאיים שניתנות באמצעות הרשויות המקומיות. באמצעות מגוון תכניות שמופעלות במימון של משרד הרווחה, המשרד לשוויון חברתי ותוכניות נוספות שיוזמות הרשויות המקומיות.

ה. הסדרת היחסים בין גורמי הטיפול בקהילה. קביעת גבולות אחריות מוסכמים וסנכרון בין המטרות, דרכי הפעולה והתוצאות הרצויות של הגופים השונים למען יצירת תמהיל מענים מיטבי וגמיש עבור אזרחים ותיקים התואם את צרכיהם ויצירת רצף טיפול מקיף וכוללני.

ו. פיתוח מערכות מידע תומכות. הצוות ממליץ למוסד לביטוח לאומי, קופות החולים, משרד הרווחה וכלל השותפים לפתח ממשק העברת מידע מהיר ויעיל בין הגופים השונים לגבי האזרחים הוותיקים בישראל, הן לגבי זכאי חוק סיעוד והן לגבי מי שנדחו (מי שהגישו בקשה

לגמלה אך בקשתם נדחתה). על אופי המידע שיועבר להיות בצורת "מטריצה תפקודית", אשר מסכמת את כלל ענייני הבריאותיים והתפקודיים של האזרח הוותיק, בדגש על אירועים חריגים.

ז. **קביעת סטנדרט אחיד ומוסכם להערכות תלות ולמידה של הדרדרות תפקודית:** יצירת מבחן תלות אחיד ומוסכם על כלל הגורמים: הביטוח הלאומי, משרד הרווחה ומערכת הבריאות, וכן קביעת מדדים נוספים לבחינת הדרדרות תפקודית לטובת הסתכלות הוליסטית על כלל צרכיו של האזרח הוותיק (ולא על ADL בלבד), ביניהם צרכיו החברתיים, הכלכליים, הבריאותיים והפסיכולוגיים למען התאמת מענה ראוי ורצף טיפולי מקיף.

ח. **השקעה במטפלות ושדרוג ההון האנושי.** הצוות קיבל דיווח על פעילותו של הצוות הייעודי בנושא, ומברך על ההחלטה לצאת לפיילוט בנוגע למודל ההכשרות של המטפלות על מנת לגבש את המודל הרצוי. מומלץ שהביטוח הלאומי יפעל ליצירת פיקוח איכותי לרמת ואיכות הטיפול של המטפלים הסיעודיים.

ט. **המלצות נוספות:** יצירת מדרג איכות לנותני השירותים ופרסומו לציבור; הגדרת מדדים להצלחת השינוי ובחינתם באופן תדיר; בחינה שוטפת של שביעות הרצון של מקבלי השירות ובני המשפחה המטפלים; המשך חשיבה על המענים שניתנים לאזרחים ותיקים סיעודיים ברמות 3-6 והתאמת המענים לצרכים; הקמת שולחנות עגולים ברשויות המקומיות לתכלול המענים שניתנים לאזרחים הוותיקים ברמה הרשותית; בחינת של תעודות מקורות ממשלתיים להשקעה בפיתוח מענים טכנולוגיים למניעת הדרדרות תפקודית ולטיפול באזרחים ותיקים במצב סיעודי; חיזוק המהלכים לאזרחים ותיקים עצמאיים שניתנים על ידי המשרד לשוויון חברתי ומשרד הרווחה; ביצוע בחינה מחודשת של מנגנון הערכת התלות; ביצוע מהלכים להגדלת הגמישות של הרשויות המקומיות בהפעלת תוכניות במימון הממשלה; תיעוד תוכניות לנושאים משלימים ושיתופי פעולה; הנגשת זכויות מוכוונות מניעה וסיוע במימושן; בחינת פוטנציאל המניעה ודחיקה של הדרדרות תפקודית במהלך ובסיום אשפוז של אזרחים ותיקים ולאחר מצבי משבר (לדוגמא, פטירת בן זוג).

מבוא ומטרת עבודת הצוות

מניעת הדרדרות בת מניעה ודחיקת התלות בזולת ככל הניתן יביאו לשימור תפקודם הפיזי והקוגניטיבי של האזרחים הוותיקים, ובכך יתרמו לעצמאותם ורווחתם החברתית והנפשית. הניסיון להבטיח כי הזדקנות האוכלוסייה תהיה מלווה בשימור איכות חייהם של האזרחים הוותיקים מצריך הפניית משאבים לתכניות ושירותי טיפול, שיקום ושימור תפקוד.

אזרחים ותיקים אשר מתגוררים בקהילה וזקוקים לעזרה בפעולות היומיום (התלבשות, רחצה, אכילה, נידודות וכו') או להשגחה בבית למען בטיחותם מוגדרים כסיעודיים. רמתם הסיעודית נקבעת על ידי המוסד לביטוח לאומי, אזי הם זכאים לגמלת סיעוד המסווגת ל-6 רמות, אותה הם יכולים לממש בקבלת שירותים ("גמלה בעין"), בכסף או בגמלה משולבת של שניהם, בגובה וביחס משתנה כתלות ברמתם הסיעודית. בשנים האחרונות גדל באופן דרמטי מספרם של מקבלי הגמלה בכ-100 אלף זכאים חדשים, עלייה של כ-56% בשלוש שנים בלבד. במקביל, עלה משמעותית שיעור זכאי גמלת סיעוד ברמות סיעוד גבוהות (רמות 3-6) לעומת הרמות הנמוכות (רמות 1-2). התפתחות זו, אשר לה עשויים לתרום מספר גורמים הפועלים במקביל, הציפה את הצורך בבחינה משמעותית של טיפול הממשלה בכלל, וגמלת הסיעוד בפרט, בסוגיית ההידרדרות התפקודית של האזרחים הוותיקים במדינת ישראל.

לפיכך, ביום 17.1.2022 החליטו שר הרווחה והביטחון החברתי, חה"כ מאיר כהן, ושר הבריאות, חה"כ ניצן הורוביץ, על הקמת צוות בין-משרדי שמטרתו בחינת כלל המענים הניתנים כיום לאוכלוסייה הוותיקה לצורך שימור תפקודה – ובראשם גמלת הסיעוד – ולגבש המלצות בנושא. בכתב המינוי לחברי הצוות נקבעו בפרט המטרות הבאות: יצירת מבנה תמריצים המקדם מניעת הידרדרות תפקודית; בחינת הממשקים בין הגופים השונים (המוסד לביטוח לאומי, משרד הרווחה והביטחון החברתי, משרד הבריאות, קופות החולים וחברות הסיעוד) וגיבוש המלצות בנושא; ייעול ההוצאה הציבורית, תוך בחינת ההוצאה הלאומית לסיעוד.

בדוח שלהלן מפורטים שיטת העבודה הצוות, ממצאיו והמלצותיו, שגובשו תוך תהליך שיתוף ולמידה מקיף.

הגדרות וממצאים

החל מינואר 2022 הצוות למניעת הדרדרות תפקודית קיים 9 מפגשים בהם נידונו מטרות הצוות וכיווני הפעולה והושמעו עמדות הגופים השותפים והחיצוניים לצוות. בנוסף בוצע הליך שיתוף ציבור במטרה לדייק את הסוגיות המרכזיות שבנידון.

תופעה בלתי רצויה והגדרת בעיה

2 שאלות עיקריות שהיו לפתחו של הצוות, והכתיבו את אופן עבודתו, נוגעות להגדרת התופעה הבלתי רצויה¹ והגדרת/הגדרות הבעיה² הנמצאות בשורש הסוגיה. בתתי הפרקים שלהלן ייסקרו העמדות וההצעות השונות, וההכרעה שהתקבלה בנושא.

התופעה הבלתי רצויה – הידרדרות תפקודית בת מניעה

מהי הפגיעה העיקרית ברווחה הציבורית הנובעת מהידרדרותם התפקודית של אזרחים ותיקים? האם התופעה הבלתי רצויה המרכזית היא עצם הידרדרותם של אזרחים ותיקים, או העלות הכלכלית והמשקית הנובעת מכך? שאלות אלו, ואחרות, זוהו כקריטיות לטובת אפיון נכון של הסוגיה דנן, ובהתאם – לגיבוש המלצות בנושא.

התפיסה המגולמת בכתב המינוי מבקשת להציב במרכז העבודה את אוכלוסיית האזרחים הוותיקים בישראל ורווחתה. בהתאם לכך הוחלט כי מוקד העבודה יהיה עצם ההידרדרות התפקודית של אותם אזרחים. לצד זאת חשוב לזכור כי באופן טבעי אוכלוסייה זו חווה שינויים תפקודיים הנובעים מהזדקנות – היחלשות שרירים, ירידה קוגניטיבית, תמורות באורח החיים ועוד, ולפיכך הוחלט כי הגדרת התופעה הבלתי רצויה תהיה "הידרדרות תפקודית בת מניעה".

יש לציין כי בהגדרת התופעה הבלתי רצויה נידונה האפשרות להתייחס גם להיבטי כמות (עלייה במספר האזרחים הוותיקים הזכאים לגמלת סיעוד) ואיכות (החמרה במצבם של הזכאים לגמלה לפי המעברים בין רמות התפקוד), אולם למרות השאיפה לאפיין – כמותנית ואיכותנית – את טיבה של התופעה הבלתי רצויה, הצעה זו נגנזה מ-2 טעמים עיקריים: ראשית, מטרת העל של הצוות היא מניעת הידרדרות תפקודית בת מניעה באשר היא, גם במנותק ממנגנון גמלת סיעוד. שנית, ישנו ספק האם אכן ניתן בהכרח להסיק מהעלייה במספר הזכאים לגמלה לגבי מצבם בפועל של האזרחים הוותיקים בישראל. דהיינו, מנגנון הגמלה הוא מנגנון ממשלתי אשר רמות התפקוד בו מוגדרות באופן מסוים, והוא מושפע ממשתנים מתעברים כגון מוטיבציות, תמריצים, ביורוקרטיה, מיצוי זכויות וכן הלאה. ככזה, אומנם בכוחו לספק אינדיקציה כלשהי למצבם התפקודי של האזרחים הוותיקים בישראל ע"פ ההגדרות הנבחרות, אך אין לראות בו אמצעי מדויק ומוחלט למדידת תפקוד, המצביע על החמרה או מגמת עלייה בקצב ההידרדרות.

¹ "תופעה בלתי רצויה", במונחי מדיניות ציבורית, מייצגת את הפגיעה ברווחת הציבור – מאפייניה, היקפיה, וכו'.
² "הגדרת בעיה", במונחי מדיניות ציבורית, מייצגת את הגורמים לתופעה הבלתי רצויה, ו/או את התחומים שבאמצעות התערבות בהם ניתן יהיה להפחית את היקף התופעה הבלתי רצויה.

הגדרת הבעיה

מפני שייתכנו מספר רב של גורמים אשר תורמים להידרדרות תפקודית בת מניעה של אזרחים ותיקים בישראל, במסגרת דיוני הצוות והחומרים שנסקרו זהו גם מספר הגדרות אפשריות לבעיה.

לאחר דיונים בנושא נבחרו על ידי חברי הצוות הגדרות הבעיה הבאות ביחס לאזרחים ותיקים עם סיכון גבוה להיות סיעודיים ואזרחים ותיקים שנמצאים ברמות הסיעוד הנמוכות:

1. היעדר תמריצים למניעת הידרדרות ברמה המוסדית.
2. קיומם של תמריצים להכרה ברמת זכאות גבוהה יותר גם בהיעדר החמרה במצבם של אזרחים ותיקים, הן מבחינת המבוטחים ובני משפחותיהם והן מבחינת נותני השירות (תמריץ כספי עקב פוטנציאל לרווח מעלייה ברמת הסיעוד), זאת בנוסף לתמריץ כלכלי שלילי לחברות הסיעוד למניעת הידרדרות תפקודית.
3. מערכת מפוצלת בין מספר רב של גורמים שאינם פועלים בתיאום, והיעדר גוף מתכלל במערכת הסיעוד שכל תכליתו היא שימור תפקוד.
4. מחסור במידע מהימן וזמין לגופים העוסקים בתחום.

ממצאים וטענות

להלן סקירה מתומצתת של הממצאים והטענות המרכזיות שהועלו במסגרת עבודת דיוני הצוות:

1. מבנה והתאמת מערכת הסיעוד לצרכים ולחברה בישראל

א. לא קיים בישראל גוף שתכליתו ומטרתו שימור תפקוד ומניעת הידרדרות תפקודית בת מניעה ואין תוכנית אסטרטגית ממשלתית לנושא. צרכיהם ומאפייניהם של אזרחים ותיקים רבים ומגוונים וניתן לחלקם לקטגוריות: צרכים בריאותיים ותפקודיים (הן היחלשות טבעית של הגוף והן חשיפה לסיכונים) צרכים סוציאליים (לדוגמא התמודדות עם תחושת בדידות ושינויים באורח החיים ובמעגלים החברתיים), צרכים פסיכולוגיים, צרכים כלכליים, צרכים תפעוליים (ניהול משק בית) ועוד. במערכת הסיעוד במובנה הכוללני קיימים מענים רבים ופרטניים לצרכים הללו, אך בולטת בהיעדרה הסתכלות רחבה על הממשקים ביניהם ו"וידוא" כי מתקיים מענה שלם למכלול הצרכים.

ב. מערכת הסיעוד מפוצלת בין מספר רב של גורמים שלא פועלים בתיאום. מקבלי הגמלה מאולצים להתנהל ולקבל שירותים מגופים שונים (ביטוח לאומי/חברות הסיעוד, קופות החולים, מחלקות לשירותים חברתיים), מה שעלול ליצור בלבול ופגיעה ברצף הטיפול ובמיצוי הזכויות. לדוגמא, נדחי גמלת סיעוד עשויים להיות בעלי פוטנציאל גבוה להתאמה לשירותים של מחלקות לשירותים חברתיים או קופות חולים (בין השאר, לטובת מניעת הידרדרות עתידית), אך אין מנגנון העברת מידע סדור ומבנה תמריצים המעודד באופן ברור את מעורבותם של גופים אלה בשלב זה.

ג. בישראל האוכלוסייה הטרוגנית (מגזרית, תרבותית, מבנה משפחתי וכו') ולפיכך ישנו צורך לתת מענים שונים לאוכלוסיות שונות.

2. הדרדרות תפקודית: החמרה, דחיקת התלות ומניעה

- ישנן הסכמות לגבי גורמים המסלימים, במישרין או בעקיפין, הדרדרות תפקודית, בין אם טרם תחילת ההדרדרות או במהלך הדרדרות קיימת. בין גורמים אלו ניתן לציין:
- א. תזונה לקויה, בין אם עקב חוסר הבנת החשיבות, הדרדרות במצב רפואי/תפקודי, חוסר אמצעים לרכוש מצרכים או חוסר יכולת לבשל.
 - ב. ניתוק חברתי ומשפחתי ואיבוד מסגרות חברתיות.
 - ג. אובדן משמעות.
 - ד. משבר נפשי ודיכאון אשר לרוב נובעים מבדידות, התאלמנות וחוויות אובדן נוספות.
 - ה. שינוי דרמטי המשליך על ההווה והפעילות היומיום (לדוגמה פרישה לגמלאות, מעבר לבית אבות וכדומה).
 - ו. איבוד מיומנויות ואוטונומיה (למשל – איבוד היכולת לנהוג).
 - ז. היעדר תעסוקה – בין אם בשכר או בהתנדבות.
 - ח. אורח חיים שאינו פעיל, הסתגרות בבית, הימנעות מפעילות גופנית.
 - ט. דעיכה קוגניטיבית.
 - י. אירועי אשפוז בבתי חולים.
 - יא. אירוע טראומתי-פיזי (נפילה, ניתוח, התקף לב, שבץ ועוד) ושיקום לוקה בחסר לאחריו.
 - יב. מרחק ממענים קיימים והיעדר יכולת ניידות עצמאית.
 - יג. טיפול לקוי במצבים רפואיים כרוניים; ירידה ביכולות השמיעה; מצב בריאות שן לא מיטבי
 - יד. תנאי מגורים "מסכנים" ושאינם נגישים, מכשולים במרחב הציבורי.
 - טו. היעדר מעקב רפואי רציף.
 - טז. חוסר התמצאות במענים הקיימים ובמימושם.
 - יז. טיפול על ידי כח אדם שאינו מיומן ושאינו מכוון לדחיקת תלות

בהמשך לאמור לעיל בנושא מבנה והתאמת מערכת הסיעוד לצרכים ולחברה בישראל, מענים והתערבויות למקרים המצוינים לעיל קיימים באופן ספורדי. למרות הסכמת גורמי המקצוע לגבי השפעתם הפוטנציאלית על הדרדרות תפקודית, חסר מידע מקיף על השפעתם המצטברת.

3. תמריצים

- א. היעדר תמריצים למניעה ראשונית ברמה המוסדית. עיקר המיקוד של הגופים המטפלים באזרחים ותיקים (בעיקר חברות הסיעוד וקופות החולים) מופנה לטיפול רפואי לפי הצורך, טיפול שיקומי לאחר אירוע טראומה (נפילה, שבץ, התקף לב וכו') או טיפול סיעודי, עם השקעה מועטה במניעת הדרדרות תפקודית ודחיקת התלות בעזרת הזולת.

ב. קיומם של תמריצים להחמרת המצב של האזרחים הוותיקים ברמה העסקית (תמריץ כספי להחמרה ברמת הסיעוד). זכאי גמלת סיעוד רשאים לבחור לקבל עד שליש מהגמלה בכסף. ככל שעולים ברמות הגמלה, שעות הסיעוד עולות (רווח לחברות הסיעוד) ולכן קיים אינטרס מבני לחברות הסיעוד שזכאי הגמלה יעלו ברמות.

יש להעמיק בבחינת מבנה התמריצים והשפעתו על חברות הסיעוד, מחלקות לשירותים חברתיים ברשויות המקומיות, קופות החולים וגופים נוספים תוך הכרה בהשפעתם של תמריצים שליליים ושימת דגש על תמרוץ מימוש תוצאות ולא תשומות ותפוקות בלבד.

4. פיקוח, בקרה ומדידה

א. אמות מידה לאיכות השירותים: היעדר אמות מידה אחידות ומוסכמות על כלל הגופים השותפים בטיפול באזרח ותיק. לפיכך קיים קושי בהגדרת התוצאות הרצויות בכלל, והתוצאות הרצויות מפעילות חברות הסיעוד בפרט, וקושי במדידת טיב השירות.

ב. היעדר כלים למדידת היעילות של מתן הגמלה (בעין, בכסף או בגמלה משולבת) על טיב הטיפול הסיעודי, מניעת ההידרדרות ודחיקת התלות ומתוך כך היעדר יכולת השוואה בין יעילות אופן צריכת הגמלה וההשפעה על דחיקת התלות והתאמה למאפייני זכאי הגמלה. מחסור באינדיקטורים לכך שגמלה בכסף אכן מנוצלת באופן עצמאי לטובת שימור תפקוד ומניעת הדרדרות.

ג. מנגנוני פיקוח ובקרה: מערכת הסיעוד סבוכה ומכילה גורמים רבים החל מקובעי המדיניות ועד המטפל הסיעודי המבקר את האזרח הוותיק בביתו. קיומם של כלי פיקוח ובקרה על איכות הטיפול והגשמת ייעודה של גמלת סיעוד והטמעת השימוש בהם לוקה בחסר.

5. מידע ומחקר

היעדר דאטה ומיפוי מדויקים של מצבים ואירועים המזרזים הידרדרות תפקודית. לאורך דיוני הצוות הועלו דוגמאות, כמפורט לעיל, למקרים ואירועים הנתפסים כנקודת מפנה לשינוי במצבם התפקודי של אזרחים ותיקים, שממנה והלאה חלה הידרדרות מואצת במצב תפקודי. למרות שישנה הסכמה תיאורטית כי אירועים אלו, בין היתר, מהווים גורמים להדרדרות תפקודית ולמרות שקיימים מחקרים מסוימים על השפעתם, ישנו מחסור קריטי במיפוי של גורמים אלו ובניתוח מהימן ותקף של השפעתם. בנוסף, חסר מידע על תוצאות תוכניות התערבות בתחום של אזרחים ותיקים ועל השפעת השינויים בגמלת הסיעוד שבוצעו ב-2018.

6. מנגנונים ומדיניות הטיפול

א. מועד ההתערבות: מוכוון לאספקת מענה למצב סיעודי קיים, לאחר עדויות להדרדרות מסוימת בתפקוד, ולא למניעתה או דחיקתה מלכתחילה.

ב. שכבת המטפלים/ות: תנאי העסקה, תנאי עבודה שוחקים, היעדר הכשרה מספקת (חברות הסיעוד מחויבות להכשרה מקצועית של 30% מקרב המטפלים/ות המועסקים אצלן), חוסר יציבות ואפשרות מוגבלת לפיתוח מקצועי. זאת לצד קושי משמעותי במדידת הצלחת הטיפול

הסיעודי. כל אלו משפיעים על איכות השירות הטיפול-סיעודי ועל הפוטנציאל של הטיפול למנוע הידרדרות מעבר לשימור ושיקום בסיסיים.

ג. בני/ות משפחה מטפלים/ות: היעדר ליווי, הנחיה, תמיכה או הכשרה מקצועית הנדרשת לבני משפחה מטפלים והיעדר כלי פיקוח אפקטיביים על פעילותם ובחינה האם שילובם של בני משפחה מטפלים עדיף על פני צריכת השירותים על ידי חברות הסיעוד.

ד. מיקוד באוכלוסיית היעד הרלוונטית ביותר: עלו שאלות בנוגע למיקוד באוכלוסיית היעד בין כלל אוכלוסיית האזרחים הוותיקים לאוכלוסייה הזכאית לגמלת סיעוד או ברמות הנמוכות בלבד. נראה כי יש מקום להתמקד באוכלוסייה הפוטנציאלית להגיע לקצבת הסיעוד בזמן הקרוב, ובאפשרויות המניעה של אוכלוסייה זו וכן באוכלוסייה הזכאית לקצבת סיעוד ברמות הנמוכות אשר ניתן לבצע מהלכים לשימור רפת תפקודם בצורה משמעותית יותר. עם זאת, יש לייעל אף את הקצאת המשאבים לכלל מקבלי הגמלה.

7. מערכת הבריאות

א. מחסור באנשי צוות רפואי, מקצועות הבריאות, מטפלים סיעודיים, כוח עזר ומיטות אשפוז – גם הם מערימים קשיים על מאמצי מניעת ההדרדרות התפקודית. בנוסף, בקרב אוכלוסיית האזרחים הוותיקים ישנן תופעות של אשפוזים חוזרים, ריבוי פניות לחדרי מיון, קושי בהגעה למרכזים רפואיים לקבלת טיפול והימנעות מקבלת טיפול רפואי ועוד. בנוסף, מערכת הבריאות וקופות החולים ממוקדת במקרים רבים בטיפול ולא מניעה.

ב. השפעת האשפוז: ישנה הסכמה כי אירועי אשפוז מייצרים הסלמה בתפקוד ו"קפיצה" לרמות הסיעוד הגבוהות, כאשר צומת מרכזי הוא המעבר מאשפוז בחזרה לקהילה. מיקוד בנקודת מפנה זו בחיי אזרח ותיק וחשיבה על התערבות מניעתית מותאמת למעטפת החברתית ולמצב הבריאותי תוכל לעכב הדרדרות תפקודית.

8. הרפורמה בסיעוד והשפעתה על כמויות ושיעור זכאי גמלת הסיעוד

בשנים האחרונות ולאור מגיפת הקורונה, לצד הגדלת האפשרות לקבלת גמלה בכסף/משולבת, הוגמשו גם תנאי הזכאות לגמלה. לדוגמא – פתיחת האפשרות לקבלת זכאות ללא ביקור אבחוני, אלא רק על סמך הגשת מסמכים רפואיים. סיבות אלו יכולות גם הן להסביר את העלייה בשיעור מקבלי הגמלה באוכלוסייה. השינויים שחלו בתחום הסיעוד בעקבות הרפורמה וההתמודדות עם מגיפת הקורונה עדיין טריים. ייתכן ואנו עדיין עדים לניסיונות התייצבות המערכת ויש לשים לב כי לא ינקטו צעדים על בסיס שינוי שמתהווה וטרם התאזן.

9. הרשויות המקומיות

לרשויות המקומיות והמחלקות לשירותים חברתיים ישנו ערך מוסף בתחום הדאגה לאזרחים ותיקים והוא בעיצוב ויצירת התנאים הפיזיים והחברתיים במרחב כמקדמי בריאות ומונעי הדרדרות תפקודית. עם זאת, בשל השונות הרבה הקיימת בין הרשויות המקומיות בישראל, קיים גם שוני מובהק ביכולותן להוות גורם אחראי בלעדי על מניעת הדרדרות של אזרחים ותיקים.

עקרונות מרכזיים למניעת הדרדרות תפקודית

בכל הנוגע למניעת הדרדרות תפקודית, קיימת הסכמה רחבה על כך שככל שהמניעה מתבצעת בשלב מוקדם יותר ("במעלה הזרם"), כך היא יעילה יותר. לפעולות מניעה ודחיקת תלות בקרב אוכלוסייה זו, אשר ככלל מצבם התפקודי אינו מצריך טיפול סיעודי אינטנסיבי, צפויה השפעה משמעותית על קצב ואופי הידרדרותם התפקודית בהמשך החיים. לאור זאת, ועל בסיס תובנות שעלו במהלך המחקר ודיוני הצוות, ממליץ הצוות על העקרונות העיקריים הבאים לשם מניעת הידרדרות תפקודית בת מניעה של אזרחים ותיקים. יודגש כי העקרונות אינם מבטלים זה את זה ויש מקום ליישם את כולם במקביל.

א. השקעה במניעה הדרדרות תפקודית עוד טרם הגעת האזרח הוותיק למצב בו הוא מוגדר כסיעודי:

1. אזרחים ותיקים עצמאיים – באמצעות מגוון תכניות שמופעלות על ידי הרשויות המקומיות במימון של משרד הרווחה, המשרד לשוויון חברתי ותוכניות נוספות שיוזמות הרשויות המקומיות.

2. אזרחים ותיקים שנמצאים בסיכון להדרדרות תפקודית – אזרחים ותיקים שביקשו לקבל גמלת סיעוד ונדחו ואזרחים ותיקים שלאור הנתונים הקיימים בקופות החולים וברשות המקומית, קיים חשש שבתקופה הקרובה תחול אצלם הדרדרות תפקודית. לקבוצה זאת מומלץ להתאים תכנית טיפול ייעודית על ידי קופות החולים באמצעות מתן תמריצים כספיים לקופות החולים למניעת ההדרדרות התפקודית שלהם, תוך מיקוד הקופות בפעולות בהן יש להן מומחיות ויכולת ותוך שמירה על איתנות הכלכלית.

ב. שילוב של שירותי דחיקת תלות ברמות הנמוכות של גמלת הסיעוד:

כיום ברמות הגמלה הנמוכות קיימות שלוש אפשרויות לבחירת האזרח הוותיק: גמלה בכסף, קבלת שירותים בעין ושילוב של השניים. ברמות הנמוכות כמעט ואין היום שירותים שמטרתם להאט את ההידרדרות התפקודית של האזרחים הוותיקים (מספר מצומצם של שירותים ברוח זו ניתן לקבל במסגרת לוח ח'2 בחוק הביטוח הלאומי המאפשר המרה של שעות הסיעוד לשירותים). בהשוואות בינלאומיות שנערכו נמצא כי אחוז הקשישים הזכאים לטיפול סיעודי בקהילה בישראל עומד על כ-25%, לעומת רק כ-10.5% בממוצע בשאר מדינות ה-OECD. זאת, אף על פי שלא קיימת אינדיקציה כי מצבם התפקודי של הקשישים שונה באופן מהותי משאר מדינות ההשוואה. לצד זאת, ניתן לראות כי רוב משמעותי של מקבלי הקצבה ברמה 1 בוחרים לקבל את הקצבה בכסף ולא בעין. על בסיס ממצאים אלה, ניתן להסיק כי מצבם התפקודי של האזרחים הוותיקים ברמות הנמוכות של גמלת הסיעוד אינו מצריך טיפול סיעודי אינטנסיבי, וכי דווקא השקעה במניעת הדרדרות בקרב אוכלוסייה זו צפויה להניב את התוצאות הטובות ביותר. אולם, כיום, שירותי הטיפול ברמות אלה אשר מסייעות לזקן בתפקודו היומיומי אינן מלוות במענים נוספים אשר יסייעו לדחיקת תלות ולשימור תפקוד, והדבר עלול לגרום דווקא

להגברת התלות בעזרת הזולת ואת קצב הידרדרותו התפקודית. לפיכך, ולאור חשיבות נושא המניעה ודחיקת התלות של האזרח הוותיק בעזרת הזולת בשמירה על איכות חייו של האזרח הוותיק, מומלץ לשלב שירותי דחיקת תלות באמצעות לוח ח'2 או באמצעות קופות החולים, וכל זאת במסגרת המשאבים המוקצים כיום לרמות הנמוכות בגמלת הסיעוד של הביטוח הלאומי.

ג. שילוב משמעותי של קופות החולים במהלכים למניעת הדרדרות טרם המצב הסיעודי וברמות הנמוכות של הגמלה:

הגורם הבריאותי, על מאפייניו השונים, מהווה את אחד הגורמים העיקריים להדרדרות תפקודית בקרב אזרחים ותיקים. בהתאמה, שמירה על אורח חיים בריא ופעיל טרם ההידרדרות התפקודית ובמהלכה, היא אחת הדרכים הבטוחות והיעילות ביותר למניעת הידרדרות.

כיום, אזרח ותיק הזכאי לגמלת סיעוד יכול לבחור בין קצבה כספית, שירותי טיפול-סיעודי בבית, שילוב בין השניים ושירותי רווחה שונים המוגדרים בלוח ח'2 בחוק הביטוח הלאומי. אולם, קופות החולים, המכירות את האזרח הוותיק לפני ולפנים, פוגשות אותו לעתים קרובות ועוקבות באופן שוטף אחר מצבו הבריאותי, אינן מעורבות כלל בשירותי הסיעוד הניתנים בקהילה ובפעולות למניעת הגעה למצב סיעודי.

בעוד שטיפול סיעודי אינטנסיבי הכולל סיוע משמעותי בביצוע פעולות יום-יום בסיסיות (רחצה, לבישה, אכילה וכו') הינו סיוע סוציאלי במהותו ואינו נמצא בליבת העיסוק של קופות החולים, פעולות ותכניות שונות שעיקרן מניעת הדרדרות תפקודית עבור אזרחים ותיקים טרם-סיעודיים ושבריריים (מניעת נפילות, תזונה ואורח חיים בריא, פיזיותרפיה, ריפוי בעיסוק וכו') מהוות חלק אינטגרלי מפעילותן השוטפת של הקופות, כך שחלקן במניעת הדרדרות משמעותי ויש להרחיבו עקב ההבנה כי פעולות המכוונות למניעה ראשונית ימנעו גם צורך בטיפול רפואי עתידי שיספקו/יכבידו על הקופות.

ד. הרחבת שירותי הרווחה לזכאים לגמלת סיעוד וביסוס שירותי קהילה התומכת:

כאמור, כיום באפשרות אזרח ותיק הזכאי לגמלת סיעוד להמיר את שעות הסיעוד להן הוא זכאי בשירותי רווחה שונים, דרך לוח ח'2 בחוק הביטוח הלאומי, ובראשם ביקורים במרכז יום וקבלת שירותי קהילה תומכת. מחקרים מראים כי לשירותים אלה חשיבות גדולה בשמירת איכות חייהם של הזכאים הסיעודיים ובדחיקת תלותם הסיעודית. כחלק מפעילותו השוטפת, משרד הרווחה שוקד על הרחבתם ושיפורם של השירותים הקיימים, לצורך יצירת מגוון ורצף שירותים קהילתיים וחברתיים תומכים לרווחת האזרחים הוותיקים. לשירותים אלה חשיבות גדולה ביצירת ערך ומשמעות לאזרח הוותיק והם מסייעים באופן משמעותי במניעת ההידרדרות התפקודית.

לפיכך, מומלץ לתמרץ את האזרחים הוותיקים להשתמש בגמלת הסיעוד לצריכת שירותים של קהילה תומכת ושירותים נוספים שמציע משרד הרווחה.

ה. שיוני מבנה התמריצים בגמלת הסיעוד:

תמריצים למקבלי הגמלה - אוכלוסיית האזרחים הוותיקים מאופיינת לעיתים בהימנעות מדרישת טיפול ו"הכחשה" של הידרדרותם התפקודית. יש צורך בפיתוח מנגנונים שיתמרצו את צריכת השירותים הזמינים. המצב הקיים, בו זכאי גמלת סיעוד רשאים לבחור את תמהיל

הגמלה ברמות השונות (בכסף/בעין/משולב) מחזק את האוטונומיה והעצמאות של מקבל הגמלה להתאים את השירותים הרלוונטיים לצרכיו, אך פעמים רבות הבחירה לצרוך את הגמלה בכסף מובילה לשימוש בכסף זה למטרות שאינן מממשות את מטרת הגמלה ואינן תורמות לשימור התפקוד, מניעת הדרדרות או דחיקת התלות. אמנם דרוש עוד מחקר בנושא, אך הצוות ממליץ לעודד צריכת גמלה בשירותים על פני גמלה בכסף. זאת ניתן לעשות באמצעים שונים: הגדרה כי ברירת המחדל היא קבלת הגמלה בעין, ליווי האזרח הוותיק בבחירת תמהיל הגמלה הנכון עבורו והדגשת חשיבות צריכת שירותים מונעי הדרדרות (בין אם דרך חברות הסיעוד, קופות החולים, הרשות המקומית, או באופן עצמאי), התניית קבלת הגמלה בכסף בצריכת שירותי מניעה ושיקום, ועוד.

תמריצים לגופים המטפלים - כיום, מרבית שעות הסיעוד הניתנות מסופקות בצורת שירותי סיעוד בבית מקבל השירות, המסופקים ע"י חברות ועמותות הסיעוד, עמן מתקשר המוסד לביטוח לאומי במכרז ייעודי ועל פי תעריף שעתי הנקבע מראש. אופן ההתקשרות כיום עם חברות הסיעוד הינו בגין שעות טיפול בבית האזרח הוותיק אך אין כל הגדרה או הקצאה של תקציב עבור שימור תפקוד ודחיקת תלות לגורמים העשויים לבצע זאת באופן מיטבי, באופן בו מבנה התמריצים שלהם מעודד אותם לבצע דחיקת תלות כאמור. לפיכך, ממליץ הצוות על מיקוד המשאבים המוקצים ברמות 1-2 למניעת הדרדרות תפקודית ע"י גורמים המסוגלים לעשות זאת באופן הטוב והיעיל ביותר תוך בניית מבנה תמריצים המעודד את שימור התפקוד של הזקנים ורואה את רווחתו במרכז. כמו כן, בין היתר, מומלץ לשלב במכרז חברות הסיעוד תמריצים לעידוד דחיקת תלות שיבוא לידי ביטוי ברמות 3-6.

ו. **חיזוק הממשקים, שיתוף הפעולה והסנכרון בין הגופים השונים - הסדרת היחסים בין גורמי הטיפול בקהילה, קביעת גבולות אחריות מוסכמים וסנכרון בין המטרות, דרכי הפעולה והתוצאות הרצויות של הגופים השונים** למען יצירת תמהיל מענים מיטבי וגמיש עבור אזרחים ותיקים התואם את צרכיהם ויצירת רצף טיפול מקיף וכוללני. המלצה זו אינה מחייבת בהכרח מינוי גורם מתכלל, אלא מיקוד בחלוקת תחומי אחריות ברורים וחיזוק שיתוף הפעולה והימנעות מכפילויות ו"חורים" ברצף הטיפול.

ז. **פיתוח מערכות מידע תומכות - נכון להיום**, סנכרון המידע בין גופי הממשלה השונים, הרשויות המקומיות, קופות החולים, גופי הסיעוד והעמותות המסייעות לאזרחים ותיקים בנוגע לזכאי גמלת סיעוד לוקה בחסר עד מאוד. לפיכך, הצוות ממליץ למוסד לביטוח לאומי, קופות החולים, משרד הרווחה וכלל השותפים לפתח ממשק העברת מידע מהר ויעיל בין הגופים השונים לגבי האזרחים הוותיקים בישראל, ובפרט לגבי זכאי חוק סיעוד.

ח. **חיזוק ההכשרה והמעמד של המטפלות - קיימת חשיבות רבה להשקעה במטפלות הסיעודיות** שנושאות בנטל הטיפול באזרחים הוותיקים הסיעודיים, תוך הכשרתן לטיפול מניעתי דוחק תלות ומשמר תפקוד. אפיק זה מתבצע בנפרד על ידי משרדי הממשלה השונים וביטוח לאומי בסיוע של צוות עבודה שהוקם בנושא ביחד עם 'אשלי'.

המלצות

מטרתו העיקרית של הצוות, כפי שבאה לידי ביטוי בכתב המינוי, היא לבחון את מבנה התמריצים בגמלת הסיעוד, תוך שימת דגש על מניעת הדרדרות תפקודית בקרב אזרחים ותיקים. במסגרת דיוני הצוות, עלה כי במצב היום לא קיים אף שחקן אשר שם את מניעת הידרדרותו התפקודית של האזרח הוותיק במקום מרכזי בפעילותו. לפיכך, עלה צורך מהותי בהסטת המשאבים הקיימים לעבר מניעה ראשונית של הדרדרות תפקודית, בדגש על הזכאים לרמות הנמוכות של הגמלה (רמות 1-2), בהקדמת מועד ההתערבות, וביצירת מנגנונים ותמריצים המעודדים את הגורמים הרלוונטיים להתמקד במניעת הדרדרות ולפעול באופן מתואם לשם יצירת רצף טיפולי ברור.

לאור זאת, ועל סמך העקרונות המרכזיים למניעת הדרדרות כפי שהוצגו בפרק הקודם, נגזרו ההמלצות המרכזיות של הצוות. המלצות אלה, המוצגות להלן, צפויות להביא לשיפור משמעותי ברווחתם של האזרחים הוותיקים באופן הגורם לכך ששימור תפקודם יהיה מטרה מרכזית של הגופים בתחום, ובאופן המשנה את הקצאת המשאבים הקיימת תוך מיקוד במניעה ושימור תפקוד של האזרחים הוותיקים.

1. שינוי מבנה גמלת הסיעוד ברמות הנמוכות (1-2)

המלצתו הראשונה והעיקרית של הצוות היא שינוי מבנה גמלת הסיעוד הקיים ברמות הנמוכות. לאור כלל הממצאים שעלו במהלך עבודת הצוות, הוחלט כי בהינתן המצב הקיים יהיה נכון יותר להתמקד בשירותי מניעה ברמות הנמוכות, ולא בשירותי טיפול, הן בשל העובדה כי קשישים אלה חווים ירידה מתונה בתפקודם, והן בשל האפקטיביות הגדולה של שירותי המניעה בשלב זה. שינוי זה לא יגרע מסך המשאבים המוקצים כיום לאוכלוסיית הקשישים ברמות הנמוכות, אלא יסיט את המשאבים הקיימים הממוקדים כיום כמעט לחלוטין בשירותי טיפול, לעבר שירותי מניעת הדרדרות ודחיקת תלות. בהתאם לכך, הצוות ממליץ על חלוקת הגמלה ברמות הנמוכות לשלושה מרכיבים עיקריים:

א. **גמלת סיעוד בכסף לאזרח הוותיק** – קצבה כספית אשר תינתן לאזרח הוותיק הזכאי לגמלה דרך המוסד לביטוח לאומי, ללא הגבלה על אופי השימוש בקצבה. רכיב זה של הגמלה יאפשר גמישות מקסימלית לקשיש, אשר יוכל להשתמש בקצבה כראות עיניו ועל פי צרכיו.

ב. **שירותי דחיקת תלות** – ישנן שתי חלופות מרכזיות למתן שירותי דחיקת תלות:

- **מתן שירותי דחיקת תלות באמצעות הביטוח הלאומי** – הגדרת השירותים הדרושים ברמות הנמוכות כשירותי מניעת הדרדרות ופיתוח משמעותי של מגוון שירותים שונים לדחיקת תלות, שיתבצע על ידי גורמים שאינם חברות הסיעוד. בניגוד למצב היום, למפעילים של תחום המניעה יהיה תמריץ משמעותי לדחוק את תלותו הסיעודית של האזרח הוותיק, שכן ככל וידרדר מצבו, אותם מפעילים כבר לא יתקצבו בגין אותו קשיש. הציפייה היא, כי הגורמים שיספקו את שירותי המניעה יפתחו מגוון שירותי

מניעה ודחיקת תלות, בשיתוף עם השחקנים הרלבנטיים, שירותים שיהיו שונים באופן מהותי משירותי הסיעוד הניתנים כיום בבית זכאי הגמלה, וממוקדים במניעת הידרדרותו התפקודית. השירותים הנדרשים ברמות הנמוכות יוגדרו מחדש ויהיו מכווני מניעת הידרדרות תפקודית, בעוד שהשירותים הנדרשים ברמות הגבוהות יהיו שירותי הסיעוד כהגדרתם היום במכרז. כל זאת באמצעות לוח ח'2 לחוק הביטוח הלאומי. לא ניתן יהיה להמיר שירותי המניעה בכסף או בטיפול סיעודי על ידי מטפלת (לגבי מבטחים ברמה 2- תיבחן האפשרות לאפשר למקבלי גמלת סיעוד הסובלים מדמנציה או תחלואה נפשית להמיר את שירותי המניעה, כולם או חלקם לטיפול סיעודי). שאר השירותים ייקבעו בלוח ח'2 תוך מתן אפשרות לאזרחים הוותיקים להמרה בכסף, אך ההמרה לא תהא מלאה, והתקציב הנחסך יוקצה לשיפור השירותים האמורים. מוסכם כי שיפור לוח ח'2 כשלעצמו אינו מספק שכן ניתן לראות כי המימוש בפועל כיום של השירותים השונים המוצעים לציבור הינו נמוך מאוד. יש לציין כי חלופה זאת הינה החלופה המומלצת והעדיפה על ידי המוסד לביטוח לאומי.

- **מתן השירותים על ידי קופות החולים** – יצירת מנגנון תקצוב ייעודי לקופות החולים בעבור מתן שירותי דחיקת תלות. בהתאם לסעיף ג' בעקרונות הצוות שהוצגו לעיל, קופות החולים הראו במהלך עבודת הצוות כי באמתחתן מגוון רחב של כלים לסייע בדחיקת התלות של האזרחים הוותיקים. כמו כן, לקופות החולים ישנו מאגר מידע משמעותי על האוכלוסייה ומפגש והיכרות רציפה עימה באופן שהקצאת משאבים תוך יצירת מבנה תמריצים למניעה יכול לסייע רבות לאוכלוסיית האזרחים הוותיקים. משרד הבריאות בתיאום עם משרד האוצר יגבש מודל תקציבי ייעודי שישמור על איתנותן הכלכלית של קופות החולים ויאפשר להן, לצד אספקת השירותים הרפואיים להן הם מחויבים מתוקף חוק ביטוח בריאות ממלכתי, לפתח תשתיות מניעה ודחיקת תלות. יש לוודא כי מתן התקציב לקופות החולים יינתן באופן שאינו מתמרץ אותן להגדיל את האוכלוסייה הסיעודית אלא דווקא לפתח תהליכי מניעה ודחיקת תלות הן לקראת כניסה למצב סיעודי והן בהתחלת הדרך במצב הסיעודי. כמו כן, יש להבטיח כי התקציב המוקצה לנושא מוגדר בצורה ברורה אך ורק לאוכלוסיית האזרחים הוותיקים. ככל שיוחלט על פתרון אחר שאינו העברת פעילות אספקת השירותים לקופות החולים הרי שיש לחשוב על אפשרויות נוספות לשילוב של קופות החולים במארג היחסים של מניעה ודחיקת תלות בנפרד ממנגנון התקצוב של הביטוח הלאומי.

ג. **הרחבת שירותי הרווחה לזכאים וביסוס שירותי הקהילה תומכת** - תקצוב משרד הרווחה באופן ייעודי למערך הקהילות התומכות, כך שכל זכאי לגמלת סיעוד ברמות הנמוכות יהיה זכאי גם באופן אוטומטי לשירותי קהילה תומכת. כמו כן, משרד הרווחה יפעל לפיתוח מענים משודרגים כך שבמסגרת הקהילה התומכת יינתן מענה של שירותי אחזקת בית, ובפרט ניקיון לזכאים המעוניינים להקצות לכך סכום נוסף מקצבתם. בכדי לתמרץ בחירה בשירותי רווחה על פני קצבה כספית, מומלץ לקבוע כי חלק מהמשאבים המוקצים לרמות הנמוכות כיום יינתנו כברירת מחדל לשירותי רווחה, אך ניתן יהיה להמירם כקצבה כספית מופחתת באופן המתעדף מתן שירותים כך שגובה הקצבה הכספית יהא נמוך מערך השירותים. ככל שהזכאים יבחרו בקצבה כספית, הסכום שנחסך יוקצה עבור שיפור השירותים לאוכלוסייה שבוחרת בכך.